3.1.7.1. 호스피스 · 완화의료 환자 진료

제 정 일	2006.07.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	완화의료센터				
유 관 부 서					

관 련 기 준	4주기 의료기관인증기준: 3.1.7 환자진료, 6.1 환자권리존중 및 보호 JCI Standard 7th Edition: PCC 2.1, 2.2, COP.3, 7

제1조 (목적)

1. 환자의 요구에 맞는 의료를 제공하고 말기 · 임종기 환자 및 완화의료 환자에 대해 신체적, 정신적, 사회적, 영적, 종교적으로 지지를 제공하기 위함이다.

제2조 (정의)

1. 말기환자(Terminally Illness)
   1) 의사와 해당분야의 전문의 1명으로부터 수개월 이내에 사망할 것으로 예상되는 진단을 받은 환자
   2) 적극적인 치료에도 불구하고 근원적인 회복의 가능성이 없고 점차 증상이 악화되는 환자
2. 임종과정
   1) 회생의 가능성이 없고, 치료에도 불구하고 회복되지 아니하며, 급속도로 증상이 악화되어 사망에 임박한 상태
3. 임종과정에 있는 환자
   1) 의사와 해당 분야의 전문의 1명으로부터 임종과정에 있다는 의학적 판단을 받고 임종과정에 있는 환자 판단서 서식이 작성된 자
4. 연명의료중단등결정
   1) 임종과정에 있는 환자에 대한 연명의료를 시행하지 아니하거나 중단하기로 하는 결정
5. 완화의료(Palliative Care) 환자
   1) 주 질환 치료가 아닌, 질환으로 인한 통증 등의 증상을 완화시키고, 정신적, 사회적, 영적, 종교적 지지를 통해 투병과정 중 삶의 질을 향상시키며, 편안하고 존엄한 임종을 위해 완화의료가 필요하여 완화의료센터로 협의진료가 의뢰되거나 완화의료병동에 입원한 환자

제3조 (절차)

1. 말기 · 임종기 환자 진료
   1) 말기 · 임종기 진료 시 고려사항
      (1) 진료 시 환자나 가족의 요구에 따라 적절한 진료를 제공
      (2) 진료의 모든 과정에 환자와 가족이 참여
      (3) 환자의 가치관, 종교, 문화적 기호, 선호도 존중
      (4) 환자와 가족의 심리적, 정서적, 정신적, 문화적 우려에 대응

(5) 부검, 장기기증 등 민감한 문제를 다룸

2) 다음의 항목을 평가하여 진료에 반영한다. 단, 응급상황은 제외한다.

(1) 통증, 구토, 호흡곤란 등 신체적 증상

(2) 신체적 증상을 완화 또는 악화시키는 요인들

(3) 현재 증상 관리와 환자의 반응

(4) 환자와 가족의 종교적 성향 및 종교 단체에서의 활동 여부

(5) 좌절, 고통, 죄책감, 용서 등 환자의 영적 필요 또는 우려

(6) 가족관계, 대처기전, 질병에 대한 환자와 가족의 반응 등 심리적 상태

(7) 환자, 대리인에 대한 지원 혹은 휴식 필요 여부

(8) 대안적 환경 또는 진료 수준의 필요 여부

(9) 가족의 병리적 슬픔 가능성 등 생존자의 위험 요인

(10) 부검, 장기기증 등 민감한 문제의 요청 여부

3) 말기 및 임종과정에 있는 환자의 연명의료중단등결정에 대한 서식 작성 절차는 세브란스병원 내규 [3.1.7.2. 연명의료결정 환자 진료]에 따른다.

2. 호스피스 · 완화의료에 대한 정보 제공

1) 정보제공 대상: 환자, 가족

2) 정보제공 방법: 병원 내 게시판, 홈페이지, 안내문 등

3. 완화의료센터 운영 및 절차

1) 완화의료팀

(1) 구성: 의사, 간호사, 사회복지사, 미술치료사, 음악치료사, 놀이치료사, 약사, 성직자, 자원봉사자 등으로 이루어진다.

(2) 역할: 완화의료 환자의 통증 및 신체적 증상 완화, 조절되지 않는 심리적, 사회적, 영적 고통 감소를 위한 완화의료 상담 및 프로그램 제공, 관련 의료진 교육 등이다.

2) 완화의료 서비스

(1) 완화의료 병동 및 외래, 협의진료 형태로 제공된다.

(2) 완화의료병동 입실 전 환자 또는 대리인에게 완화의료병동 입실 동의서를 받는다.

(3) 치료계획: 환자와 가족의 요구 및 문제를 평가하고 치료계획을 수립한다.

(4) 정기적인 완화의료팀 미팅을 통해 환자 사례에 대한 증례 연구를 하고 효과적인 환자 돌봄에 대한 의견을 교환하고 기록한다.

(5) 말기환자 및 임종과정에 있는 환자와 가족에게 의료진으로부터 연명의료중단등결정에 대한 설명이 이루어진 경우 이에 대한 정보를 제공하고 가족을 지지한다.

(6) 문상, 위로 편지, 상담 등을 통해 사별가족의 슬픔을 위로하고, 6개월 이상 슬픔에 잠겨있는 가족들은 정신건강의학과의 도움을 받도록 한다.

(7) 소아청소년 환자의 경우 필요 시 소아청소년 완화의료팀에 의뢰하여 환아 또는 그 가족 구성원들의 상담과 교육을 통해 환아의 임종과정을 돕고, 사별 이후 가족의 슬픔 치유 과정이 촉진되도록 돕는다.

4. 말기 · 임종기 환자 진료 프로세스
   1) 법정서식 작성
      (1) 연명의료 결정법에 따른 법정서식을 작성한다.
      (2) 서식의 종류
         ① [9호] 임종과정에 있는 환자 판단서
         ② [1호] 연명의료계획서
         ③ [10호] 연명의료중단등결정에 대한 환자의사 확인서(사전연명의료의향서)
         ④ [11호] 연명의료중단등결정에 대한 환자의사 확인서(환자가족 진술)
         ⑤ [12호] 연명의료중단등결정에 대한 친권자 및 환자가족 의사 확인서
         ⑥ [13호] 연명의료중단등결정 이행서
      (3) 서식은 '연명의료계획서 철회 신청서' 작성하지 않는 한 유효하다.
   2) 정보 공유
      (1) 연명의료 정보조회 화면을 통해 연명의료 법정서식 작성 현황 확인
      (2) DNR 팔찌착용

5. 말기 · 임종기 환자 진료 및 완화의료 서비스의 질을 평가한다.

6. 말기 · 임종기 환자 또는 완화의료 환자 진료에 참여하는 의료진은 관련 교육을 이수한다.

제4조 (부록)

제5조 (참고)

내규의 제 · 개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)
1. 이 내규는 2006년 7월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)
1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인 : 세브란스병원장 이 강 영 (인)